

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: PLANO DE AÇÃO CORRETIVA – REGULAÇÃO MÉDICA E PRIORIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1. SUMÁRIO EXECUTIVO E ANÁLISE DO FATO GERADOR

A regulação médica imediata transcende a eficiência operacional; ela constitui o alicerce da sustentabilidade jurídica e da integridade financeira desta operadora. Falhas na identificação de casos críticos não apenas geram passivos assistenciais, mas comprometem severamente a licença de operação perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). É imperativo que esta Diretoria compreenda que a celeridade decisória em casos de urgência é o único mecanismo capaz de neutralizar tutelas de urgência e garantir a continuidade do negócio em um ambiente regulatório cada vez mais punitivo. **Análise do Incidente Crítico** Em 26/02/2026, às 10:33, registrou-se uma falha inaceitável no fluxo de autorização em São Paulo: um beneficiário com quadro tumoral e perda funcional de visão sofreu um atraso superior a 24 horas para a liberação do procedimento cirúrgico. A demora em um cenário de agravamento clínico progressivo é injustificável sob qualquer ótica técnica ou administrativa. **Enquadramento Legal e Regulatório** O evento configura violação direta e grave aos seguintes dispositivos:

- **Art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998:** Estabelece a obrigatoriedade de cobertura imediata para casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de **lesões irreparáveis**. No caso em tela, a perda de visão é a materialização jurídica exata da lesão irreparável, o que torna a negativa ou o atraso um descumprimento legal flagrante.
- **Art. 3, XVII da RN 566/2022:** Impõe o atendimento imediato para situações de urgência e emergência, sem margem para filas de espera burocráticas. **Avaliação do "So What?": Impacto e Passivo** O descumprimento do prazo de 24 horas para casos de urgência/emergência, conforme o **Art. 12, V, 'c' da Lei 9.656/1998**, atua como gatilho automático para a judicialização. A inércia da operadora nestas janelas críticas não apenas eleva o custo assistencial por meio de condenações por danos morais e materiais, mas também fragiliza a defesa institucional, uma vez que a violação do direito à saúde, diante de risco de lesão irreparável, é de difícil reversão em instâncias superiores. **Conectivo:** Após definir a gravidade do fato gerador, é imperativo diagnosticar as falhas estruturais que permitiram tal ocorrência.

2. DIAGNÓSTICO DOS GARGALOS OPERACIONAIS E FALHAS DE FLUXO

A manutenção da eficiência operacional exige a segregação absoluta entre fluxos de alta complexidade e fluxos de emergência. A ausência de uma distinção clara permite que a burocracia administrativa paralise decisões médicas soberanas, gerando um risco assistencial desnecessário e uma exposição jurídica latente. **Mapeamento de Ineficiência** A auditoria identificou que a solicitação foi indevidamente retida na fila de "Auditoria Médica Padrão para Alta Complexidade". Este fluxo ignora o caráter emergencial do tumor com perda funcional, tratando uma situação de risco de lesão irreparável sob o mesmo SLA de procedimentos eletivos. A falha reside na ausência de sinalização de prioridade clínica no front-end do sistema de autorização. **Auditoria de Canais de Atendimento** identificou-se a ineficácia absoluta do SAC e dos canais de atendimento ao prestador. Múltiplos

acionamentos realizados pelo hospital foram ignorados ou retidos em níveis administrativos básicos, evidenciando que não há um protocolo de escalonamento que conecte o prestador diretamente ao decisor técnico (auditor de plantão) em casos críticos. **Avaliação do "So What?": Exposição Regulatória** A inexistência de um mecanismo de "fast-track" assistencial e a sobreposição de processos burocráticos sobre critérios médico-assistenciais violam o **Art. 1º, §1º, 'f' da Lei 9.656/1998**. Ao permitir que conceitos financeiros ou administrativos obstruam o atendimento de emergência, a operadora subverte a natureza do contrato de saúde, atraindo a fiscalização rigorosa da ANS e elevando o risco de sanções por cerceamento de cobertura. **Conectivo:** Compreendidos os gargalos, o relatório detalha a seguir a reestruturação mandatória para a mitigação dos riscos identificados.

3. PLANO DE AÇÃO CORRETIVA: REESTRUTURAÇÃO DAS FILAS E SLAs

A garantia das coberturas assistenciais mínimas exige uma transformação tecnológica e processual. A triagem automatizada e o escalonamento de plantão devem ser implementados como mandatos prioritários para os departamentos de TI e Operações, eliminando a discricionariedade humana em situações de risco de vida ou lesão. **Determinações e Prazos Operacionais:**

1. **Segregação em Tempo Real (Sistema):** Exige-se a criação de um sistema de triagem automática para pedidos enquadrados no **Art. 35-C da Lei 9.656/1998**. Todo pedido sinalizado como emergência deve gerar um alerta vermelho com SLA de atendimento **imediato**.
2. **Fluxo de Escalonamento Crítico (Fast-Track):** Estabelecer diretrizes para que o SAC e canais hospitalares acionem diretamente a Auditoria Médica de Plantão em casos de risco iminente, eliminando intermediários administrativos.
3. **Governança em Oncologia (Monitoramento Rígido):** Em conformidade com a **Lei 14.307/2022**, deve-se instituir uma lista de verificação rigorosa para o prazo de **10 dias úteis** para fornecimento de antineoplásicos (**Art. 12, §5º da Lei 9.656/1998**). Embora o incidente atual seja cirúrgico, a falha de fluxo exige a revisão integral dos prazos oncológicos para evitar novos gatilhos.
4. **Garantia de Acesso e Indisponibilidade:** Na ausência de leito ou rede credenciada apta, deve-se aplicar o **Art. 33 da Lei 9.656/1998**, garantindo acesso imediato em acomodação superior ou rede alternativa sem ônus ao beneficiário. **Conectivo:** A eficácia deste plano de ação é a única barreira contra as severas sanções administrativas e financeiras previstas pela ANS.

4. COMPLIANCE E MITIGAÇÃO DE RISCOS SANCIONÁRIOS

Sob uma visão estratégica de compliance, a aderência estrita às diretrizes médico-assistenciais da **RN 465/2021** e seus anexos é o que protege o patrimônio da operadora. É fundamental compreender que o Rol de Procedimentos é uma referência básica mínima (**Art. 10, §12**), mas nunca um teto absoluto que justifique a omissão diante de lesões irreparáveis, conforme o **Anexo II (DUT)**. **Matriz de Riscos Financeiros e Administrativos**

- **Multas Pecuniárias:** O descumprimento de prazos e a negativa de cobertura em emergência fundamentam multas baseadas no **Art. 27 da Lei 9.656/1998**, com valores que oscilam entre **R\$ 5.000,00 e R\$ 1.000.000,00 por infração**, impactando diretamente as provisões técnicas.

- **Regimes Especiais:** Alertamos para o risco iminente da aplicação do **Art. 24 da Lei 9.656/1998** , que prevê o **regime de direção fiscal ou técnica** e a **Suspensão de Comercialização de Produtos** (**Art. 15 da RN 566/2022**). Tais medidas paralisam o crescimento da operadora e destroem o valor da marca.**Avaliação do "So What?": Responsabilidade dos Administradores** A conformidade preventiva é o único escudo para os gestores. Conforme o **Art. 24-A da Lei 9.656/1998** , a decretação de regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial implica na **indisponibilidade imediata dos bens dos administradores** . Ressalte-se que esta sanção atinge a todos que estiveram no exercício das funções nos **doze meses anteriores** ao ato, criando um nexo de responsabilidade solidária que exige ação imediata desta Diretoria para regularizar os fluxos assistenciais.**Conectivo:** Este relatório encerra-se com a recomendação de implementação imediata para assegurar a conformidade normativa e a proteção jurídica da diretoria.